

TEMA 1.11 • PEDIATRÍA

Diarrea en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.039

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diarrea en Pediatría

Diarrea Aguda

Causas

- **Viral** (más frecuente): **Rotavirus** (el más común; fiebre alta, frecuente en verano y salas cunas) - **Bacteriana**: *E. coli*, *Shigella* → cuadro autolimitado en la mayoría

Tratamiento según Grado de Deshidratación

TABLA 1.11.1: PLAN VS DESHIDRATACIÓN

PLAN	DESHIDRATACIÓN	CRITERIO	TRATAMIENTO
A	Leve / Sin deshidratación	Pérdida < 5% del peso	Sales de rehidratación oral (SRO) 100–200 cc después de cada deposición. También se puede usar agua.
B	Moderada	Pérdida 5–10%, signos de deshidratación (mucosas secas, lágrimas ↓)	SRO 50–100 cc/kg en 4–6 horas. Fraccionar si vómitos.
C	Severa	Pérdida > 10%, shock hipovolémico, IRA	Suero fisiológico EV en bolo: 20 cc/kg . Si no se puede canalizar: vía intraósea (tibia).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los jugos, bebidas gaseosas y líquidos hiperosmolares están **contraindicados**: prolongan la diarrea.

- **Indicaciones absolutas de hidratación EV:**
- Vómitos que impiden la hidratación oral
- Compromiso de conciencia
- Íleo paralítico / distensión abdominal progresiva
- **Tratamiento sintomático (Sí se pueden dar):**
- Antieméticos (si vómitos)
- Antipiréticos (paracetamol si fiebre)
- Antiespasmódicos (si cólico)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los **antidiarreicos** están **contraindicados** en niños (agravan las complicaciones bacterianas).

- **Antibióticos (excepción a la regla de no dar ATB):** Solo en:
- Mal estado general + disentería + fiebre alta + dolor intenso (sospecha *Shigella* o *E. coli* enteroinvasora)
- Coprocultivo positivo para *Shigella*
- ATB: **Ciprofloxacino** VO (elección) o **Cefotaxima** EV (si paciente grave, séptico)

NOTA CLÍNICA

Las quinolonas están contraindicadas en niños en general, pero el ciprofloxacino es la excepción en diarrea bacteriana invasiva.

Diarrea Crónica en Pediatría

1. Diarrea Crónica Inespecífica (la más frecuente)

- **Causa:** Ingesta de jugos hiperosmolares → diarrea osmótica - **Clínica:** Lactante o preescolar, diarrea crónica intermitente, examen físico **normal**, **buen incremento de peso** - **Diagnóstico:** Clínico - **Tratamiento:** Suspender jugos + educación

2. Giardiasis

- **Causa:** *Giardia lamblia* (parásito unicelular) - **Clínica:** Preescolar/escolar, zona rural, diarrea + **flatulencia y distensión abdominal** + dolor cólico; puede dar síndrome de malabsorción completo - Si varios familiares afectados simultáneamente → sospechar giardiasis - **Diagnóstico:** Parasitológico de deposiciones - **Tratamiento:** **Tinidazol** (1ª línea) o metronidazol

3. Enfermedad Celíaca

- **Causa:** Reacción inmune al **gluten** (trigo, cebada, centeno; y avena por proteína similar) - **Clínica:** Inicia ~1 año de vida (cuando se introduce gluten), síndrome de malabsorción: bajo peso, esteatorrea, signos carenciales (anemia ferropénica por déficit absorción duodenal del hierro) - **Diagnóstico:** 1. Anticuerpos **antitransglutaminasa** (+ antiendosimio) → también para seguimiento 2. Biopsia duodenal: atrofia de vellosidades + hiperplasia de criptas + infiltrado linfoplasmocitario - **Tratamiento:** Dieta **estricta sin gluten** de por vida. Si no responde → evaluar adherencia midiendo anticuerpos

4. Fibrosis Quística

- **Causa:** Enfermedad genética autosómica recesiva - **Clínica:** - Síndrome de malabsorción intestinal (insuficiencia pancreática exocrina) - **Síntomas respiratorios:** SBO recurrente, neumonías por *Pseudomonas aeruginosa* o *S. aureus*, bronquiectasias - **Clave EUNACOM:** Diarrea + neumonías recurrentes por *Pseudomonas* → pensar fibrosis quística - **Diagnóstico:** **Test del sudor** (mide cloro en sudor): - < 40 mEq/L: normal - 40–59 mEq/L: indeterminado → confirmación genética - **≥ 60 mEq/L: fibrosis quística confirmada** - **Tratamiento:** Multidisciplinario: antibióticos anti-*Pseudomonas* y anti-*S. aureus* (profilácticos o ante infección), soporte nutricional, enzimas pancreáticas VO, soporte respiratorio, **trasplante de pulmón** (único que mejora la supervivencia a largo plazo)

5. Alergia a la Proteína de Leche de Vaca (APLV)

- **Prevalencia:** ~4% de los lactantes (1 en 25) - **Clínica:** Lactante con fórmula (o LM si la madre consume lácteos): - **Síntomas gastrointestinales** (más frecuentes): diarrea crónica, reflujo, hemorragia digestiva baja, lesiones perianales - Síntomas alérgicos: exantema, asma, rinitis - **Diagnóstico:** Prueba terapéutica de **4 semanas** + reintroducción: - Si mejora con la suspensión → reintroducir → si reaparecen síntomas: diagnóstico confirmado - Si con LM: suspender lácteos a la madre - **Tratamiento:** - Si fórmula: cambiar a **fórmula hidrolizada** (proteína hidrolizada de leche de vaca) - Si LM: **dieta sin lácteos para la madre**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 14 meses con diarrea acuosa profusa hace 2 días, vómitos frecuentes y rechazo a líquidos. Al examen: ojos hundidos, mucosa seca, piel con turgencia disminuida, llanto sin lágrimas, frecuencia cardíaca 155/min. ¿Cuál es el plan de rehidratación?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diarrea en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Plan A: <5% deshidratación → SRO en casa 50-100 mL/kg en 4h; Plan B: 5-10% → en centro 100 mL/kg 4h SRO
- Plan C: >10% deshidratación → Ringer lactato EV 100 mL/kg en 3h (lactante) o 2h (niño)
- Rotavirus: diarrea acuosa + vómitos sin sangre <2 años; vacuna a los 2 y 4 meses de vida
- Alergia proteína leche de vaca (APLV): 4% lactantes; diarrea + vómitos + dermatitis; fórmula hidrolizada
- Enfermedad celíaca: anti-transglutaminasa IgA + biopsia duodenal; diarrea crónica + déficit estatural
- Fibrosis quística: cloro en sudor >60 mEq/L; esteatorrea + infecciones pulmonares recurrentes

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIARREA EN PEDIATRÍA)**PREGUNTA 1**

Niño de 14 meses con diarrea acuosa profusa hace 2 días, vómitos frecuentes y rechazo a líquidos. Al examen: ojos hundidos, mucosa seca, piel con turgencia disminuida, llanto sin lágrimas, frecuencia cardíaca 155/min. ¿Cuál es el plan de rehidratación?

- A)** Plan A: suero oral en casa, 50-100 mL/kg en 4 horas
- B)** Plan B: suero oral en centro de salud, 100 mL/kg en 4 horas bajo supervisión
- C)** Plan C: rehidratación EV con Ringer lactato 100 mL/kg en 3 horas
- D)** Antidiarreico (loperamida) + suero oral
- E)** Antibiótico empírico oral + suero oral

PREGUNTA 2

Lactante de 4 meses con lactancia materna exclusiva presenta deposiciones con sangre, dermatitis atópica y vómitos frecuentes. Sin fiebre ni mal estado general. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el manejo?

- A)** Enterocolitis bacteriana – antibióticos y hospitalización
- B)** Alergia a proteína de leche de vaca – dieta de exclusión materna o fórmula hidrolizada
- C)** Intolerancia a la lactosa – fórmula sin lactosa
- D)** Fibrosis quística – test del sudor
- E)** Enfermedad celíaca – suspender gluten

PREGUNTA 3

Niño de 3 años con deposiciones líquidas con moco y sangre, fiebre 39°C, dolor abdominal. Coprocultivo positivo para *Escherichia coli* O157:H7. ¿Cuál es la conducta correcta respecto a los antibióticos?

- A)** Iniciar azitromicina para acortar la evolución
- B)** Iniciar ciprofloxacino para eliminar la bacteria
- C)** No usar antibióticos; rehidratación y seguimiento con hemograma y creatinina
- D)** Iniciar ceftriaxona EV por riesgo de bacteriemia
- E)** Metronidazol por sospecha de *Giardia* o *Clostridium*

RESUMEN: DIARREA EN PEDIATRÍA

Los jugos, bebidas gaseosas y líquidos hiperosmolares están contraindicados: prolongan la diarrea. Los antidiarreicos están contraindicados en niños (agravan las complicaciones bacterianas). Las quinolonas están contraindicadas en niños en general, pero el ciprofloxacino es la excepción en diarrea bacteriana invasiva.